

La Unidad de Continuidad Domiciliaria

El paciente crónico transita entre el domicilio, la atención primaria, los especialistas, la guardia, la internación y las residencias, y casi nadie es responsable de mantener la continuidad entre todos. La Unidad de Continuidad Domiciliaria existe para cubrir ese espacio.

EL PRINCIPIO QUE LA GUÍA

Respetar el proyecto de vida

VIII. Toda intervención debe respetar el proyecto de vida del paciente. El mejor tratamiento no siempre es el más agresivo: es el que, además de ser adecuado, respeta cómo esa persona quiere vivir. Curar no siempre es posible; cuidar con sentido siempre lo es.

El paciente vive una película. El sistema sanitario vive fotografías. Nuestra responsabilidad es preservar la coherencia de toda la película.

EN PROFUNDIDAD

Gestionar la incertidumbre

Buena parte de las consultas a la guardia no nacen de una emergencia real, sino de que el paciente o su familia no saben interpretar un cambio. La incertidumbre genera miedo, y el miedo, decisiones impulsivas. La continuidad transforma esa incertidumbre en conocimiento.

La Unidad de Continuidad Domiciliaria no gestiona episodios. Gestiona la incertidumbre.

EN LA PRÁCTICA

Los tres pilares

- **Confianza** — no es solo un valor humano, sino una intervención clínica: cuando el paciente sabe que hay un equipo que lo conoce, deja de buscar seguridad en la alta complejidad.
- **Educación** — una familia formada observa mejor.
- **Observación distribuida** — convierte los microcambios en decisiones precoces.

Así, no todo termina en la guardia ni en una internación: cada situación va al recurso que aporta más valor.

LA IDEA PARA LLEVARTE

La Unidad de Continuidad no es un recurso más del sistema: es el elemento que lo mantiene unido alrededor de la persona.